

9- Le Coeur_Dynamique du Mouvement Developpemental

On va voir cette croissance énorme et cet enroulement de l'embryon. On voit ici uniquement la cavité viteline. Au-dessus, on a coupé la cavité amniotique. Croissance longitudinale, flexion. Je vois mon système nerveux, là. Je vois les sommités et je vois les systèmes vasculaires. Je vais vous demander de porter attention sur un orifice, ici, qu'on appelle l'orifice futur du cellulome intra-embryonnaire. Vous voyez, il faut l'imaginer, ici. On le retrouve ici, là. Tu vois ? Qui, plus tard, va intégrer ce cellulome externe en un cellulome interne. La croissance énorme de mon système fait que mes deux tubes endocardiques primitifs se rapprochent de la ligne médiane, parce qu'ils ont une vitesse de croissance différentielle. Notocorde, qui influence cette information. rapprochement de mes deux tubes endocardiques, et une partie ici au-dessus, ça va devenir mon intestin comme on a vu, et en tour ici, ça va former ce qu'on appelle la cavité intra-embryonnaire. Ça va former ce qu'on appelle, pas la cavité péritoniale, mais à ce stade-là, plus haut, la cavité péricardique. La vésicule viteline, qui va se rapprocher pour former la partie supérieure de l'intestin. Bon, ensuite, le rapprochement de mes deux tubes endocardiques, ici, pour former la zone de tube cardiaque qui se développe, ok ? Donc, on le voit non seulement comme ceci, mais aussi comme ceci. Je vous ai montré un mouvement où ça fait ça, et maintenant, on voit le même mouvement, comme ceci. Donc, c'est une combinaison des deux qui se rapprochent de ma ligne médiane, comme ceci, mais au même moment, j'ai un mouvement où le cerveau fait ça. On pourrait dire que c'est une cavité cardio-pleuro-péritoniale, mais qui sera après complètement intégrée, séparée par mon diaphragme, en une cavité cardio-pleuro-péritoniale, et puis uniquement péricardique sur un tube. Le tout premier mouvement, sur un plan spécifique, énergétique, En même temps, j'ai toute cette phase migration-là, j'ai toute cette synchronique de développement. et maintenant, dans sa

dynamique, je me retrouve ici. C'est en même temps que j'ai cette phase de flexion de l'embryon, et j'ai ce rapprochement vers ma ligne médiane, comme ça. Les pouces, c'est cette rencontre, c'est le premier mouvement, au niveau du cœur. Le cœur, c'est une vue sagittale, il est là, il se rencontre comme ça. Le cœur, il veut se développer. Où est-ce qu'il a l'espace ? Il n'a plus d'espace derrière. Il n'a pas un grand espace à gauche ni à droite. Il n'a qu'un espace devant. Et au sein même du cœur, il va avoir son propre fulcrum. Ça, c'est l'arrière. Donc, il se développe vers l'avant. Il fait ceci, ce qu'on appelle le mouvement en looping du cœur. Ça, c'est la phase 2, on va dire. Il continue à se développer, qui fait que ça va former ici un troisième niveau, C'est-à-dire que l'espace entre le système ventriculaire et l'oreillette devient un point d'appui qui fait que le ventricule qui est au-dessus va devenir en dessous par rapport à mon système. Ça va faire un mouvement d'inversion, comme ça. Premier mouvement, c'est un rapprochement vers ma ligne médiane et une rencontre. Deuxième mouvement, ça fait un mouvement comme ça. Troisième mouvement qui va apparaître, c'est en rapport avec le processus d'inversion. C'est un processus de développement de ma cavité péritoneale. Vous vous souvenez, à un moment donné, le développement du foie va faire qu'il va y avoir une bascule sur le mouvement. Et on va avoir l'arrière-cavité des épiploons qui va déplacer ma bronche sous-gauche, un peu plus haut ici, par rapport à ma droite, liée au processus axial qu'on appelle la rupture de la symétrie. Donc, je vais avoir un mouvement de développement, cette fois-ci, vers l'avant, mais aussi vers la gauche. J'ai une double bascule, comme ça. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est surtout le rapprochement vers ma ligne médiane de mon cœur, puis le développement vers l'avant, et en même temps, un développement vers la gauche. Je vais avoir tout le système sinusoïde du foie qui va se mettre vers le haut après, par cette bascule, comme ça. Donc, premier

mouvement. Deuxième mouvement, ce sera en rapport avec ma bascule. Troisième mouvement qui va organiser mes gros vaisseaux au-dessus. Si tu regardes un cœur, tu vois qu'il est vraiment basculé, tu vois qu'il est vraiment maintenu ici par un axe qui avale. Il se maintient par rapport à ce plan vasculaire, avec un développement plus important ici, et mon axe ici, comme ceci. C'est un équilibre entre la partie thoracique, la partie abdominale ici, et la partie viscérale basse. Un mouvement très important entre le cœur ici, je prends sous l'estomac là, et là, j'ai le foie. Le mouvement, ça va faire ça. Un point de référence très important à rééquilibrer. Je me mets ici, et je regarde si le mouvement hépatique vient vers moi, si j'exagère, comme ceci ou comme ceci. et je regarde le mouvement qui part. Donc, pas de problème ici. Ce foie veut bien aller dans son mouvement de développement. Il n'est pas en retrait. Il s'arrête un tout petit peu ici. J'ai une toute petite arrêt maintenant ici. Maintenant, si je me mets au niveau du cœur, le cœur, dans son développement, il va faire l'inverse. Je viens ici, j'exagère mes mouvements, ça fait ceci. Le développement, c'est un mouvement développemental. Par contre, il y a une trajectoire. Il y a comme une empreinte. Je me mets sur l'empreinte embryonnaire. Je vais juste aller là où il veut, et c'est là où il y a le point de silence. Par exemple, ici, je veux bien, mais de nouveau, elle pourrait aller un peu plus loin. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un ici qui veut avancer là, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui la freine. Donc, il faut l'aider. Tout ça, c'est l'organisation de mon cœur qui est fortement organisé par mon foie. Donc, bien comprendre l'importance du foie. Dans l'embryologie biodynamique, on n'impose pas. Je ne rejette pas les coudes faciales. Je ne rejette pas le côté fluide. Je ne rejette pas les techniques structurelles, viscérales ou autres. Je vais m'adapter en fonction de ce que je ressens dans le moment présent. Mais la force thérapeutique, elle est là. La plus belle puissance où elle peut le mieux

émerger, c'est cette force qu'on retrouve dans la rencontre de mes deux neutres. Ce n'est pas toujours évident d'avoir les deux neutres. Par contre, si tu y arrives, c'est fantastique. Mais des fois, on peut faire une technique structurelle. Par rapport à ce que j'écoute ou je n'écoute pas, c'est à toi de choisir là où tu te sens lumineux. Dans l'ostéopathie biodynamique, quand on rentre dans ces processus, ces processus de régénération utilisent ces mouvements embryonnaires. Là, je n'ai pas fait une thérapie. Je vous ai montré les mouvements, les mouvements développementaux embryonnaires qui peuvent apparaître dans les processus thérapeutiques donnés par la marée. Il faudra juste reconnaître la fréquence sur laquelle je suis. Parfois, je vais vous montrer un mouvement. Attention, je ne suis pas dans le processus thérapeutique. Je vous montre l'empreinte du développement de l'embryon. On touche rarement un cœur en premier. Le cœur se forme par l'écho de la périphérie. Le cœur, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce qu'il reçoit une information très importante par le « neural crest ». Le cœur reçoit une information électrique, encore plus puissante sur un plan neurologique. Ça veut dire qu'on peut apprendre à sentir le cœur à distance ou le cœur se sent à distance. Il a une puissance, il a un rayonnement. Ils ont mesuré qu'il était jusqu'à 5 mètres minimum de la personne. Et probablement que c'est aussi lié à ce « neural crest » ici. C'est une puissance électrique. C'est là sur le plan veineux qu'il va y avoir un développement qu'on appelle le sinus veineux du cœur. Et dans ce sinus veineux va apparaître la réunion de mes veines cardinales, de mes veines ombilicales et tout à fait au centre de mes veines vitellines qui vont subir un tas de remaniements qu'on étudiera lorsqu'on va voir le système veineux en détail. Le cœur a un environnement facial, a sa propre électricité pour son battement cardiaque. Cette électricité ne suffisait pas à maintenir le cœur dans sa juste fonction et qu'il était dépendant dans son fonctionnement de

tout l'environnement facial. Le ligament sterno-péricardique, frénico-péricardique, vertébro-péricardique et jusqu'en haut avec la horte etc. suspendu jusqu'au tubercule pharyngien. Ce système soutenait la rythmicité du cœur. Dans le système, il y a un système oscillation fermé, j'ai oublié un O, et dans la façon dont c'est construit, quand on regarde la structure tissulaire, moléculaire de ce système d'attache, par le cœur qui bat, le tissu qui est autour va subir un mouvement d'étiration, mais la façon dont il est construit, tu vois, par ses fibres, c'est un peu comme si j'avais un élastique qui était ici et un élastique qui était là-bas. Je tire ici, parce que l'élastique, parce que l'élastique me ramène là, par le battement du cœur. Je tire ici, mais plus je tire, plus j'ai une force qui me ramène. Mais plus je tire par ici, plus j'ai une autre force qui me ramène aussi. Ça veut dire que dans la structuration même du fascia tissulaire du péricarde qui soutient le cœur, le cœur lui-même est soutenu dans sa rythmicité par son environnement facial. Tout le système facial, tout le système facial du cœur qui est ici autour peut influencer le rythme du cœur, l'importance de la liberté structurelle de l'environnement cardiaque. C'est là où je pense qu'on a une action directe. Systole-diastole, il faut voir le cœur comme un octopus. La crosse aortique et tout le tronc jusqu'au niveau de ces jonctions ici. Une grande poule comme ça, mais pas juste le corps, mais jusque dans ses tentacules, tu vois. Très loin dans mon ventre, je peux le sentir dans ma gorge, je peux le sentir dans mes pieds, vous pouvez le sentir dans vos doigts. Ça veut dire qu'une déstabilisation de la hanche peut déstabiliser le cœur. Il y a des gens qui ont des arythmies Et en fait, si vous libérez les hanches, vous les libérez ici. Il y a toute une relation par l'endothélium, ce tissu qui relie tout le système.